ACTIVACIÓN DE EQUIPO
De Respuesta Rápida

HOSPITAL REGIONAL MONTEQUIRÁ E.S.E
Crecemos para cuidar tu Salud

Fecha: 20/01/26 Hora: 10 : 40

I

NOMBRE	EDAD:	UBICACIÓN
Karol Paulina Guerrero Cuello	11	☒ Ginecología ☐ Salas de cirugía
	COVID	☒ Sala de partos ☐ Urgencias
DOCUMENTO	EG: ____ SEM	☐ Otros: ☐ UCI
1055126194	PUERPERIO: X	¿Cuál? ____

D

DIAGNOSTICO (S) PRINCIPAL (ES)

- ☐ Crisis hipertensiva ☐ Sepsis ☐ Eclampsia
- ☒ Código rojo ¿Causa? Tono X Tejido ____ Trauma ____ Trombina ____
- ☐ Cesárea de emergencia ¿Causa? ____
- ☐ Otro ¿Cuál? ____

E

ESTADO CLINICO ACTUAL	SIGNOS VITALES	CLASIFICACIÓN
• Estable X	• TAS 131 TAD 63 mm/hg	• TRIAGE ____
• Inestable ____	• FC 134 LPM	• MEOWS ____
• Sangrado activo: SI ___ NO ___	• FR 18 RPM	• QSOFA ____
• Convulsiones: SI ___ NO ___	• T 36 °C	• Indice Choque 1.0
	• SO2 92 %	• Otra ____
	• FCF ___ LPM	

A

ACTIVIDADES REALIZADAS:

- REANIMACIÓN HÍDRICA: Si X No ____ ¿Cuánto? ____
- OXIGENO: Si X No ____ FiO2 ____
- MEDICAMENTOS:
  - Código rojo: Si X No ____ ¿Cuáles? OXITO / MGH / MISO
  - Antihipertensivos: Si ___ No ___ ¿Cuáles? ____
  - Antibioticos: Si ___ No ___ ¿Cuáles? ____

S

SOLICITUDES PENDIENTES

- ☒ Laboratorios
- ☒ Hemoderivados
- ☒ Salas de cirugía
- ☐ Unidad de Cuidado Intensivo
- ☐ Referencia
- ☐ Especialistas
  - ____
  - ____
  - ____

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

LISTA DE CHEQUEO HEMORRAGIA POSTPARTO (HPP)

Nombre Edna Guerrero Identificación 1073600 Edad 25 a

Hospital HRM Ciudad Departamento

HPP ETAPA 3

Sangrado >1500 cc, índice de choque > 1.5

REPETIR ABCDE (descrito en etapa 1)

- ☐ Preparar al paciente y al equipo para iniciar protocolo de transfusión masiva
- ☐ Iniciar protocolo de transfusión masiva
- ☐ Continuar con medicamento uterotónicos
- ☐ Avisar al equipo quirúrgico- Alertar y preparar quirofano
- ☐ Decidir procedimiento quirúrgico; histerectomía - cirugía de control de daños
- ☐ Solicitar gases arteriales, ácido láctico y fibrinógeno
- ☐ Avisar al equipo médico, Cirugía general, UCI
- ☐ Desarrollar un plan
- ☐ Comunicar al equipo médico y a la familia de la paciente-

PROTOCOLO DE TRANSFUSIÓN MASIVA

- 3 Unidades de glóbulos rojos
- 2 Unidades de plasma
- 8 Unidades de crioprecipitado

☐ **Medicamentos**

Continuar administrando medicamentos de etapa 1 y 2

☐ **Acciones**

Lograr hemostasia, intervención basada en la etiología de la HPP.

☐ **Banco de sangre**

Solicitar 3 unidades de glóbulos rojos, 2 de plasma y 8 de crioprecipitado

- Si Fibrinógeno < 200 iniciar reposición con 8 unidades de crioprecipitado o iniciar reposición con 3 gramos de concentrado de fibrinógeno
- Si el sangrado es activo y las plaquetas < 50.000, iniciar transfusión 1 aféresis plaqueta

HPP ETAPA 2

Colapso cardiovascular - Sangrado abundante, coagulopatía

- ☐ ACTIVAR CÓDIGO AZUL
- ☐ Reanimación CABD
- ☐ Iniciar bolos de cristalpides 500 cc
- ☐ Iniciar paquetes de transfusión masiva descritos en etapa 3
- ☐ Avisar al equipo quirúrgico- Alertar y preparar quirófano
- ☐ Decidir procedimiento quirúrgico: Histerectomía, cirugía de control de daños
- ☐ Avisar al equipo médico- Cirugía general, UCI
- ☐ Manejo en Unidad de Cuidados Intensivos

☐ **Medicamentos**

☐ Reanimación hemostática avanzada

☐ **Acciones**

☐ Lograr revertir el colapso cardiovascular, intervención basada en la etiología

HOSPITAL

Diagnóstico del choque hipovolémico

El parámetro más alterado es el indicador más sensible

Tiempo (minutos)	Pérdida de volumen (%) y ml para una mujer entre 50-70Kg	Perfusión: Sensorio	Perfusión: Pulso	Presión Arterial sistólica (mm/Hg)	Grado del choque	Trastorno: Uresis	Trastorno: Pco	Trastorno: Esquizocitos	Trastorno: Tiempo de Protrombina
5' Diagnóstico	15-25% 750-1500 mL	Normal y/o agitada	90-100	80-90	Leve	Oliguria	Palidez-Sudoración	Presencia moderada	Prolongado 3 segundos
10' Manejo médico	26-35% 1500-2000 mL	Agitada	100-120	70-79	Moderado	Oliguria	Palidez, Sudoración	Presencia moderada	Prolongado 3 segundos
15' Colocación TANN	>35% >2000 mL	Letargo o confusión	>120	<70	Severo	Anuria	Palidez, Sudoración	Presencia moderada	Prolongado 3 segundos
20' Colocación del balón									
30' Definir respuesta									

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

LISTA DE CHEQUEO HEMORRAGIA POSTPARTO (HPP)

Q.3V

Nombre Karol Daniela Cuervo Identificación 1055126194 Edad 21

Hospital HRM Ciudad Montería Departamento Córdoba

Reconocimiento temprano HPP

☐ Identificar y anunciar: sangrado acumulado ___ cc Hora inicio sangrado ___

ACTIVAR CÓDIGO ROJO OBSTÉTRICO PEDIR AYUDA

Signos vitales al momento de activar código rojo

- Frecuencia cardiaca 134 / Tensión arterial sistólica 131
- Índice de choque valor inicial 1.0
- Índice de choque a los 15 min 1.0
- Índice de choque a los 30 min 0.7

☑ Activar código rojo obstétrico, traer carro rojo.
☑ Designar al Líder del equipo
☐ Designar una función a cada integrante del equipo
☑ Asegurar barandas de la cama
☐ Monitoría no invasiva de signos vitales cada 2 minutos

Identificar etapa de la HPP

HPP ETAPA 1

Sangrado 500-1000cc, Índice de choque <0,9
Tiempo de sangrado <10 minutos

A
☐ Asegurar vía aérea y monitorizar la tensión arterial y los signos vitales cada 2 minutos

B
☑ Administrar sumplemento de oxígeno con mascarilla con reservorio a 10 lt/min para asegurar la saturación de oígeno >95%

C
☑ Asegurar dos accesos venosos 16G o 18G y tomar muestras para laboratorio
☐ Administrar 500 cc de cristaloides (precalentar 30 segundos en microondas)
☑ Iniciar tratamiento farmacológico

1. **Oxitocina:** 40 unidades en 500 cc de solución salina a 60 cc/hora por bomba de infusión
Hora de inicio 10:12
2. **Metilergonovina:** 0.2 mg IM cada 20 minutos las primeras dos dosis y luego cada 4 horas. Máximo 5 dosis
1 dosis 10:40 2 dosis 11:03
3. **Misoprostol:** 800 mcg sublingual o 800 mcg intrarectal
Hora de administración 10:43
4. **Ácido tranexámico:** 1 gramo intravenoso en infusión rápida
1 dosis 12:10 2 dosis ___

D
☑ Diagnóstico diferencial: causas de la HPP, piense y trate las causas

1. Tono: atonía uterina	3. Tejido: retención placentaria
2. Trauma: cervical, vaginal o uterino	4. Trombina: coagulopatía o deficiencias

E
☐ Exposición: evitar hipotermia

HOSPITAL

HPP ETAPA 2

Sangrado 1000-1500 cc, Índice de choque 0.9-1.4

REPETIR ABCDE (descrito en etapa 1)

☑ Colocar traje antichoque (TANN)
☐ Colocar Balón intrauterino
☐ Hora de colocación 12:09 Insuflación 300 cc
☐ Taponamiento vaginal con compresas estériles, si se coloca el balón intrauterino
☐ Realizar Test de taponamiento. Alertar al equipo si el sangrado es >200cc en 10 min
☑ Llamar a segundo Ginecólogo. Nombre Andrea Moreno
☑ Definir si se requiere una cirugía hemostática B-Lynch
☑ Solicitar gases arteriales, ácido láctico y fibrinógeno
☑ Avisar al equipo quirúrgico- Alertar sala de cirugía
☑ Control de hipotermia (mantas térmicas, líquidos endovenosos calientes)
☑ Administrar segundo bolo de cristaloides (500cc) si la TAS< 90 y/o TAM < 60 mmHg
☑ Informar al familiar sobre la situación clínica y los pasos a seguir

Medicamentos

☐ Administrar medicamentos de Etapa 1
☑ Iniciar cubrimiento antibiótico
☐ Adicionar segunda dosis de Metilergonovina 0.2 mg intramusculares
Adminisitrar segunda dosis de ácido tranexámico 1 gramo intravenoso

Administrar dosis única de antibiótico
- Ampicilina Sulbactam 3 gramos IV, o alternativa:
- Ceftriaxona 2 gramos IV + Metronidazol 500 mg

Banco de sangre

☑ Preparar al paciente y al equipo para transfundir las unidades de glóbulos rojos
☑ Solicitar y transfundir 2 unidades de gobulos rojos

Acciones para controlar HPP

- Desgarro vaginal: realiace sutura
- Desgarro complejo: empaquetamiento y embolización
  - Solicitar apoyo de radiología intervencionista
- Restos placentarios: complete revisión de cavidad de forma manual
  - Decida si es necesario realizar curetaje
- Atonía de segmento uterino: Complete la colocación del Balón de Bakri
- Inversión uterina: reestablezca su posición, si es necesario use anestesia general
- Colapso materno ==> embolismo de líquido amniótico
  - Asegure la vía aérea y uso agresivo y temprano de vasopresores

Gobernación de Boyacá | Salud

HOJA DE SEGUIMIENTO A INTERVENCIONES HEMORRAGIA OBSTETRICA

Solicite a Médicos y enfermeras a cargo del caso registrar en la siguiente hoja las órdenes que considere necesarias para el manejo del caso y las acciones realizadas. Al final de la hoja debe registrar los nombres de los profesionales a quienes se realizó la Asistencia Técnica.

HORA CASO HIPOTÉTICA	ORDENES Y ACCIONES MÉDICAS REALIZADAS	INTERVENCIONES ENFERMERÍA REALIZADAS
MINUTO 16+10	20/1/26: 4+19. Monero expulsivo + Alumbramiento activo. - Cavidad Trauma contenida masaje uterino AB + oxitocina POS alumbramiento uterino - Cristaloides 500cc 16+40 - Se activa código ROJO Se reserva a UCI - Traje anticaídas. Balon Bakri. Transfusión 1U GRE.	2 accesos venosos.
MINUTO	+ LEV. 1.500cc 3 Bolos. - Ringer 500cc + Oxitocina. Cefazolina. 2gIVL. Ac. Tranexamico - Hospital. - Heimlerabonina #3.	
MINUTO	Se recibe a ICONTEC Seven = 1610. Acido tranexamico 2da heimlerabonina	

Gobernación de Boyacá | Salud

MINUTO	17+03. terapia resp. + gases. 17+09: Balon back. – 3000 l. (?) +
	Tratamiento. Transfusión 1 UGRE. 17+10: nueva adherencia choque. Toma gases arteriales Toma glicemia central. Admin insulina 3 u.
MINUTO	18+50: se translada a unidad de cuidados intensivos.
MINUTO	18+50 se desactiva ERE. pte en UCI.

Gobernación de Boyacá | Salud

APOYO A LA INTERVENCIÓN ACCIONES HEMORRAGIA OBSTÉTRICA

INTERVENCION	DEFINICION	0=NO 1=SI	ASISTENCIA TÉCNICA Y BARRERAS IDENTIFICADAS
IMPLEMENTACIÓN DEL TRIAGE OBSTÉTRICO	Evaluación inmediata al ingreso a la IPS de la clasificación Triage Obstétrico para definir la prioridad en la atención, mediante instrumento objetivo y por escrito. Esta actividad puede ser llevada a cabo por Enfermera Profesional o Médico General. (No es válido que la realice profesionales en entrenamiento ni auxiliares de enfermería)	No aplica	
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO	Se registran en la HC la búsqueda activa de anemia en el anteparto o en el parto en mujeres que ingresan en fase activa • Se solicita Hb y Hematocrito o Hemograma si no hay recientes (menor a un mes) • Signos clínicos de anemia. • Se indagan factores de riesgo de HPP (documento Guía HPP PQSV) o Placenta previa o Abruptio o Cesárea de emergencia o Von Willebrand o Corioamnionitis o Cesárea electiva o Embarazo múltiple o Macrosomía > 4500 gr o Polihidramnios o Multiparidad o HELLP o Parto instrumentado o Inducción T de parto o Obesidad (IMC 30)	1	

	o Antecedente de HPP o Cesárea Previa o Trabajo de Parto prolongado o Edad mayor 40 años		
IMPLEMENTACIÓN DE LA ESCALA DE ALERTA TEMPRANA DE LA EMERGENCIA OBSTÉTRICA	Se responde SI, si se encuentra implementada la escala, bien sea manual o en la historia clínica electrónica.. El instrumento se usa para la ALERTA, como su nombre lo indica, si ya se identifica la emergencia, debe activarse al Equipo de Respuesta Inmediata a la Emergencia Obstétrica y el seguimiento de Constantes Vitales depende del tipo de Emergencia y se debe realizar en la Historia Clínica de acuerdo a los lineamientos de la Res. 3280		
MANEJO ACTIVO DEL ALUMBRAMIENTO	Se debe registrar en la HC el manejo activo del alumbramiento tanto en parto vaginal como en cesárea (Resolución 3280/18)	1.	
ALERTA DE CÓDIGO ROJO	Se registra SI al encontrarse un sistema de alerta a los profesionales para acudir a la atención integral de la gestante (Anestesiólogo, Ginecólogo, Pediatra, Médicos Generales, Enfermeras, Laboratorio, Banco de Sangre – SI APLICA) Tienen claro que el código Rojo puede ser activado por CUALQUIER integrante del equipo de salud que note que la usuaria está en choque y con sangrado evidente o no. El sistema de Alerta debe estar claro y debe haber sido socializado, puede ser mediante Whatsapp, parlante, llamada, pero asegurar la respuesta inmediata. Anexar soporte	1	Grupo whatsapp. ROJA estrategia IDEAS

CLASIFICACION OPORTUNA DEL CHOQUE HEMORRAGICO	De acuerdo con los lineamientos y a la evidencia actual, se encuentra disponible en la Sala de Partos, Quirófanos, Salas de recuperación y Hospitalización Obstétrica la Tabla de Clasificación del Choque (Anexo 6 Resolución 3280 de 2018) Se registra SI, si en el transcurrir del caso se identifica oportunamente el choque (SE CLASIFICA INMEDIATAMENTE CON LOS HALLAZGOS) Se registra NO si desconocen el anexo, no lo usan o no se encuentra en los sitios indicados.	1	
MANEJO MÉDICO ADECUADO	El manejo debe ajustarse al lineamiento y a la evidencia actual: 1. Accesos Venosos #2 idealmente con yelcos 16-18. 2. Oxigenoterapia para mantener Sat > 95% 3. Sonda vesical 4. Fluidoterapia con cristaloides a 39°con bolo inicial de 30 cc/kg 5. Bolos de 500 cc cada 30 min según respuesta 6. Oxitocina dosis según vía del parto (ver Res 3280/18) 7. Misoprostol 400-600 mcg VO 8. Metilergonovina 0,2 mg IM 9. Acido Tranexámico 1 gr IV a dosis de 1 cc/min y segunda dosis en 30 min si persiste sangrado. 10. Maniobras iniciales de masaje uterino bimanual, revisión uterina si es requerido Si algún ítem hace falta, se registra NO. Se realiza asistencia técnica e identificación de barreras.	1	

SE SOLICITAN LOS PARACLINICOS REQUERIDOS	El manejo debe ajustarse al lineamiento y a la evidencia actual, solicitar paraclínicos ante sospecha de coagulopatía y en contexto de reanimación - Tiempos de Coagulación - Fibrinógeno (si está disponible) - Gases Arteriales con Lactato Sérico Si algún ítem hace falta, se registra NO. Se realiza asistencia técnica e identificación de barreras.	1	
PREVENCION DE LA INFECCION	Se recomienda a todas las mujeres que requieren manejo conservador o quirúrgico para Hemorragia Obstétrica el uso de antibioticoterapia profiláctica Ampicilina 2 gr DU o Clindamicina 600 mg DU + Gentamicina 80 mg IV En caso de requerir manejo con Balón de Bakri la antibioticoterapia se mantendrá a dosis terapéutica em tiempo que el Balón permanezca en el Útero.	1	
USO OPORTUNO DE HEMODERIVADOS	El manejo debe ajustarse al lineamiento y a la evidencia actual. • Debe iniciarse trasfusión de 2 UGRE sin cruzar O negativo en los casos clasificados como Choque moderado, en los primeros 20 minutos de reconocerse el choque en este estadio. • Si no hay disponibilidad de sangre O negativo, deberá usarse O positivo sin cruzar. • En casos clasificados como Choque Severo debe solicitarse e iniciarse Kit de Trasfusión Masiva dentro de los primeros 20-30 min de reconocido en choque severo (6 UGRE que incluyen las dos iniciales- 6 U de plaquetas	1	

	6 U de plasma Fresco congelado) • Ante la sospecha de coagulopatía inicie Plasma Fresco Congelado a relación 1:1.5 U de GRE trasfundidas. • Contemple la decisión y disponibilidad de usar Crioprecipitados y Complejo Protrombínico ante Hemorragia Severa sin respuesta o Catastrófica Teniendo en cuenta que el instrumento evalúa la Baja complejidad, se registrará SI en caso de disponibilidad de las dos unidades de sangre iniciales y el conocimiento del manejo básico en hemoderivados. Sin embargo, se realizará asistencia técnica del manejo completo.		
MANEJO CONSERVADOR **BALON DE BAKRI** **TRAJE ANTICHOQUE**	El manejo debe ajustarse al lineamiento y a la evidencia actual: • Hay disponibilidad de Balón de Bakri en la Institución en el Kit de Emergencia Obstétrica. • Hay disponibilidad de Traje Antichoque TANN en la institución en el Kit de Emergencia Obstétrica. • Se ha realizado socialización y capacitación a los profesionales en la inserción del Balón de Bakri, el uso del Balón Hidrostático con preservativo y el Traje antichoque TANN en los últimos 6 meses (Soporte) Si alguna respuesta es negativa se diligenciará como NO para realizar los ajustes pertinentes basados en la Asistencia Técnica.	1	

MONITORIZACIÓN	El manejo debe ajustarse al lineamiento y a la evidencia actual: Debe constar en el registro de la Historia Clínica - Toma de SV cada 15 min (Sensorio, FC, TA, perfusión) - Toma horaria de la diuresis - Registro de resangrado, atonía. - Pulsioximetría - Use mantas calientes para prevenir la hipotermia.	1	
TRASLADO O REMISIÓN	De acuerdo con lo requerido por la usuaria fue ingresada oportunamente a Unidad de Alta Dependencia Obstétrica (UADO) o a Unidad de Cuidados Intensivos (Si está disponible) Se registra oportuno en cuanto la gestante cumple criterios de ingreso a UCI - Compromiso de órgano blanco - Necesidad de monitoreo hemodinámico invasivo o no invasivo. - Choque severo o catastrófico - politrasfusión - Compromiso de la Vía aérea que requiera ventilación mecánica. Se puede registrar oportuno si la usuaria fue remitida en ambulancia MEDICALIZADA si esta disponible, a nivel mayor de complejidad, dentro de las primeras 2 horas de identificado el evento urgente que no pueda ser atendido en la IPS.	1	
VIGILANCIA DEL PUERPERIO	Independientemente de la vía del parto: - Se registran los signos vitales (completos), globo de seguridad, vigilancia del sangrado cada 15 min las primeras 2 horas - Se registra diuresis horaria.	1	

	- En caso de cesárea es valorada por anestesiólogo antes del traslado a piso - En caso de requerirlo, es manejada en UADO, UCI intermedios o UCI según disponibilidad.		
ADHERENCIA A GUIAS Y TRABAJO EN EQUIPO	Se indaga acerca de la socialización y actualización de Guías de Hemorragia Obstétrica en los últimos 6 meses (Soporte). Se recomienda la realización de Simulacros grabados. Se evidencia conocimiento del equipo completo de los protocolos y guías de Hemorragia Obstétrica, saben dónde consultarlas, trabajan en equipo con buena comunicación y órdenes claras.		

REGISTRO DE PROFESIONALES QUE RECIBEN LA ASISTENCIA TÉCNICA Y PARTICIPAN DEL CASO

NOMBRE	DOCUMENTO	PROFESION
Catalina Camacho	Ginecología.	
Natalia Sánchez	medico general.	
Andrea Mario	Ginecología	
Isabel Orta	Jefe enfermera.	
Angie Rivero.	Aux enf.	
Fabio Andres Bello		
Brayan Cely	Aux UCI.	
Luisa Mario	Jefe enfermeria.	